



Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Faculté de médecine d'Alger | Année universitaire 2024-2025
Département de Médecine dentaire | 2^{ème} année médecine dentaire

Module d'ODF : Approche psychologique de l'enfant

Dr MELOUAH





Plan du Cours : Le Parcours de Soin

- **Introduction**



- 1. Principes de l'approche psychologique
- **2. Rencontre de l'enfant au cabinet dentaire**
 - 2-1 Rencontre avec l'enfant et ses parents
 - 2-2 Classification du comportement de l'enfant au cabinet dentaire (Frankl et coll.)



- **3. Rencontre de l'enfant dans la pratique des soins**
 - 3-1 Soigner par la parole
 - 3-2 Capter l'attention
 - 3-3 Dédramatiser les instruments
 - 3-4 Observer une progression dans les soins

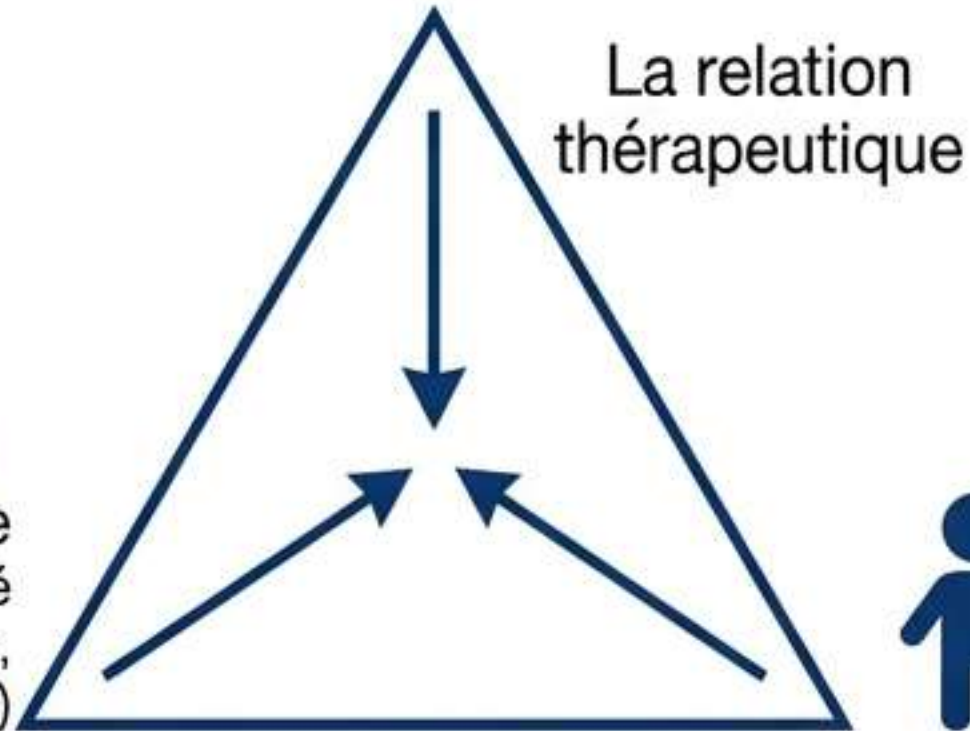


- **4. Méthode Tell-Show-Do**
- **Conclusion & Bibliographie**

Introduction : La Relation Thérapeutique

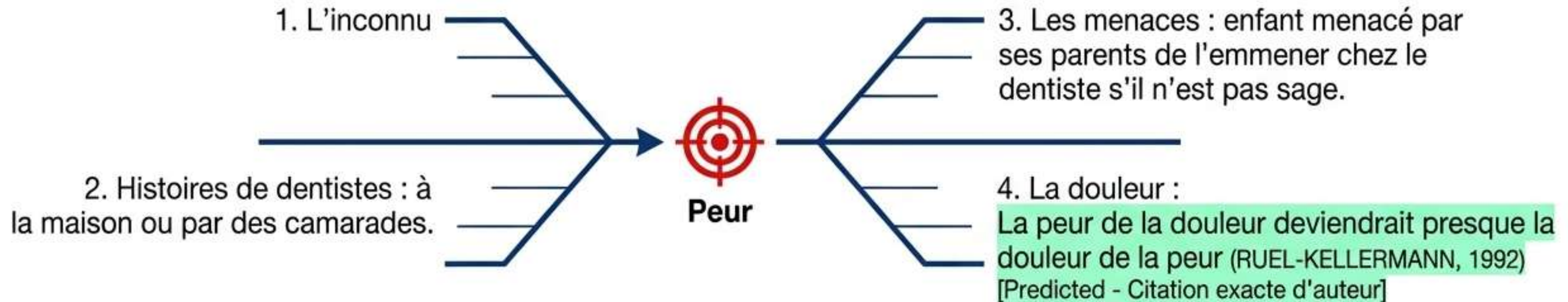
L'enfant est déjà informé, ou motivé par ses proches.
Il a une idée particulière des soins.


Un adulte
(émotivité propre, veut soigner)




Un enfant
(psychologie, raisonnement, émotivité, façon de réagir)

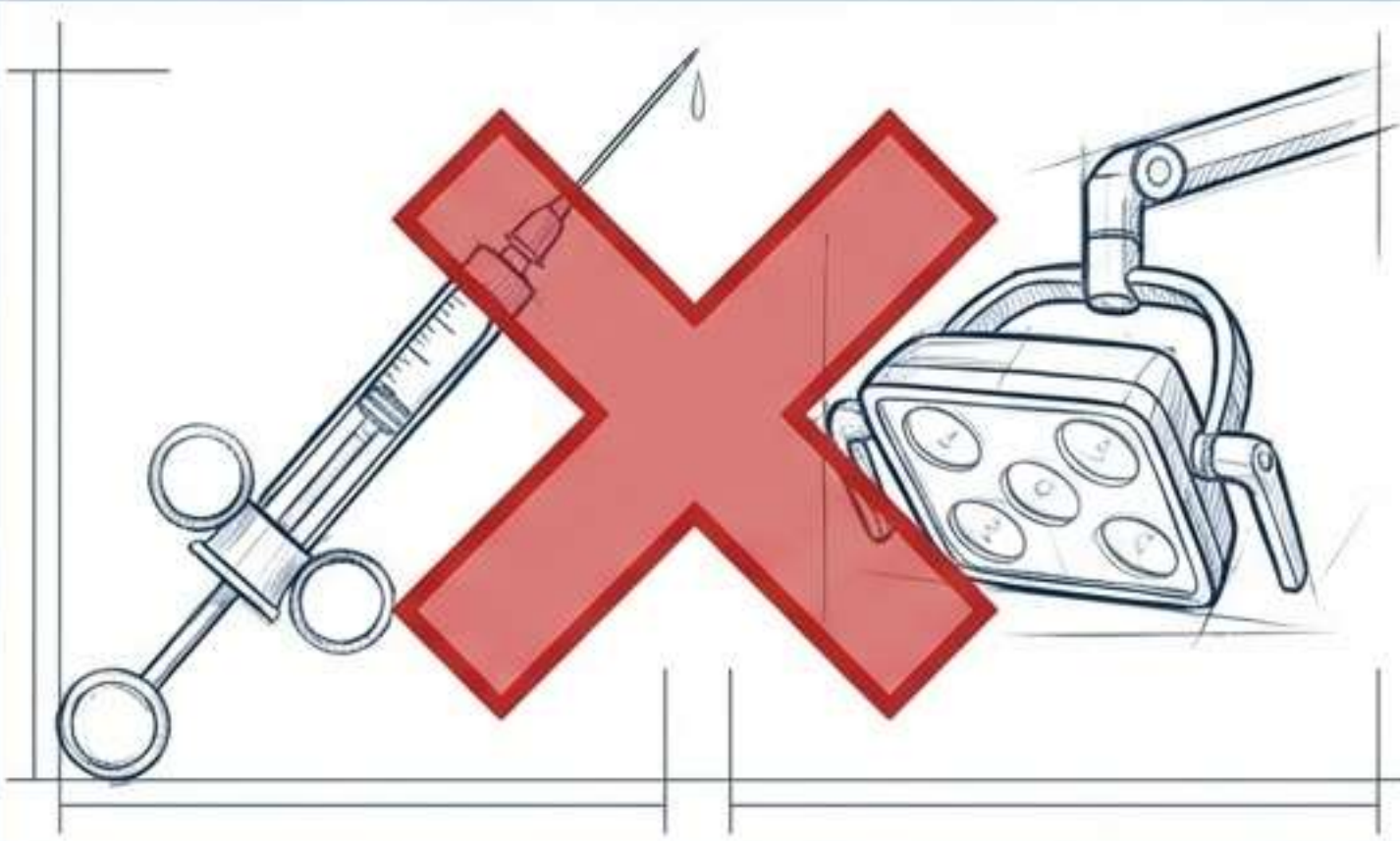
L'Étiologie de la Peur lors de la 1^{ère} visite (4 Raisons) :



Objectif : L'acquisition des fondements de la psychologie infantile est nécessaire pour les dentistes traitant de jeunes patients.

1. Principes de l'approche psychologique

À Éliminer (Sources d'Angoisse) :



À Favoriser (Aller à la rencontre) :



- * Familiariser le patient avec l'installation, les instruments, et nous-mêmes.
- * L'enfant doit venir à notre rencontre réciproquement.

Il faut essayer de gagner sa confiance [Ref: Q19 (2022)]

- * **Minimiser** son angoisse et sa peur.
- * **Éliminer** tout aspect étranger, agressif, frustrant ou humiliant des gestes et paroles.
- * **Accessoires déclencheurs** : Des accessoires qui ne font objectivement pas mal (pompe à salive, rouleaux de coton salivaire...) peuvent déclencher des réactions de peur.



Autorité



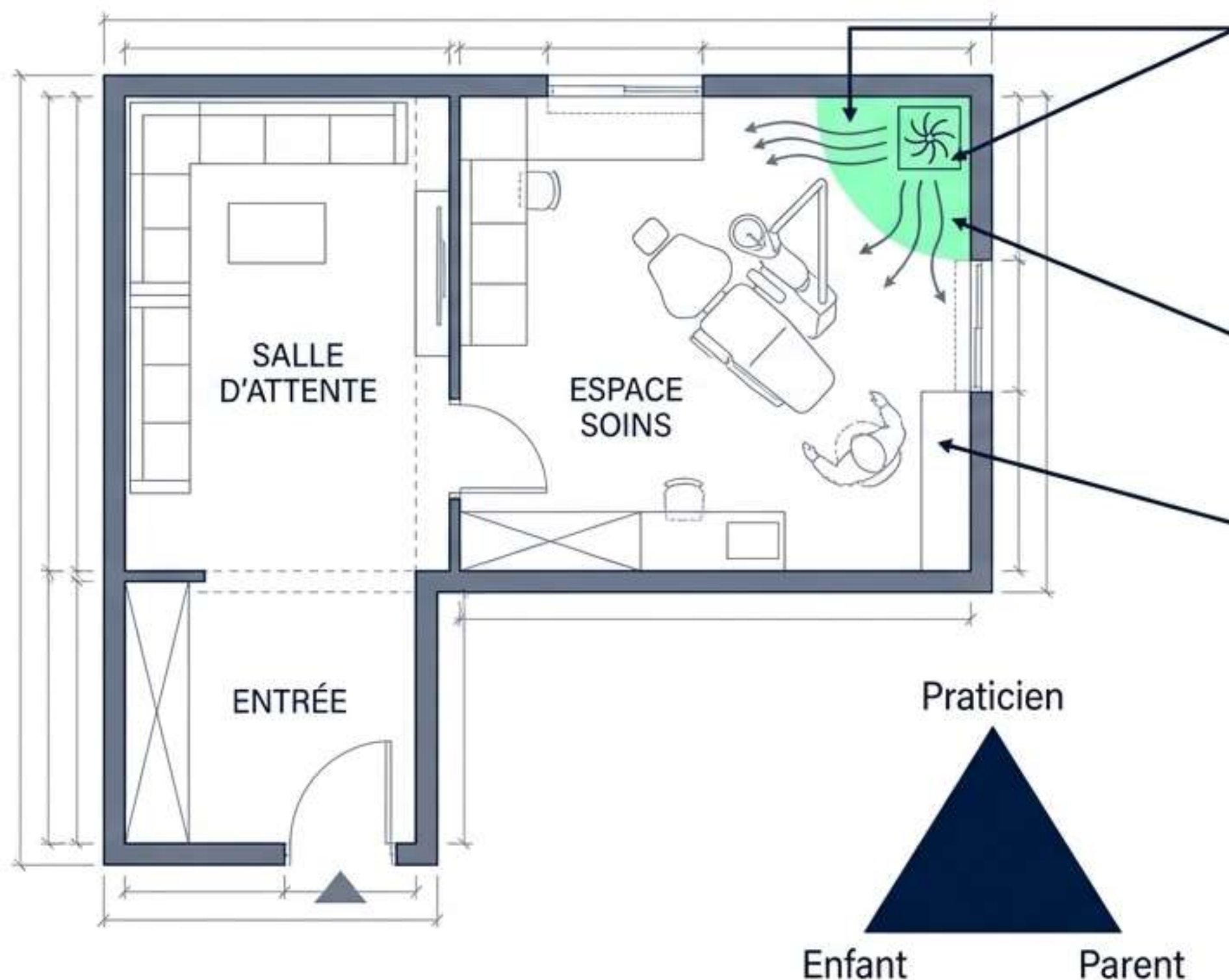
Amitié



Susciter la confiance.

(Permet de l'encourager, stimuler son amour propre et l'amener à surmonter lui-même son angoisse).

2-1 Rencontre de l'enfant et ses parents



L'Environnement Clinique :

* **Vue** : Locaux agréables visuellement et aérés (pas forcément décorés comme un spécialiste). Lumière non trop agressive.

* **Ouïe** : Ambiance musicale légère bienvenue.

Odorat : Oublier les odeurs qui rappellent l'hôpital (cortège de mauvais souvenirs) [Predicted - Détail d'environnement clinique]

* **Tenue** : Port du masque n'est pas utile. Blouse colorée recommandée.

Relation Triangulaire (Enfant-Parent-Praticien) :

* Tenir compte des remarques des parents : comportement général (maison, école), expérience antérieure du milieu médical.

* Percevoir l'attente des parents et comprendre le motif de la consultation (indispensable pour la suite).

2-2 Classification du comportement (Frankl et coll.)



Classification la plus connue, fiable à 85% [Predicted - Chiffre statistique direct]



Stade I : « Enfant définitivement négatif » : refuse le traitement, pleure et tremble de peur
[Ref: Q1 (2024)]

Stade II : « L'enfant est négatif » : éprouve de la répugnance à accepter le traitement, n'est pas coopératif
[Ref: Q6 (2023)]

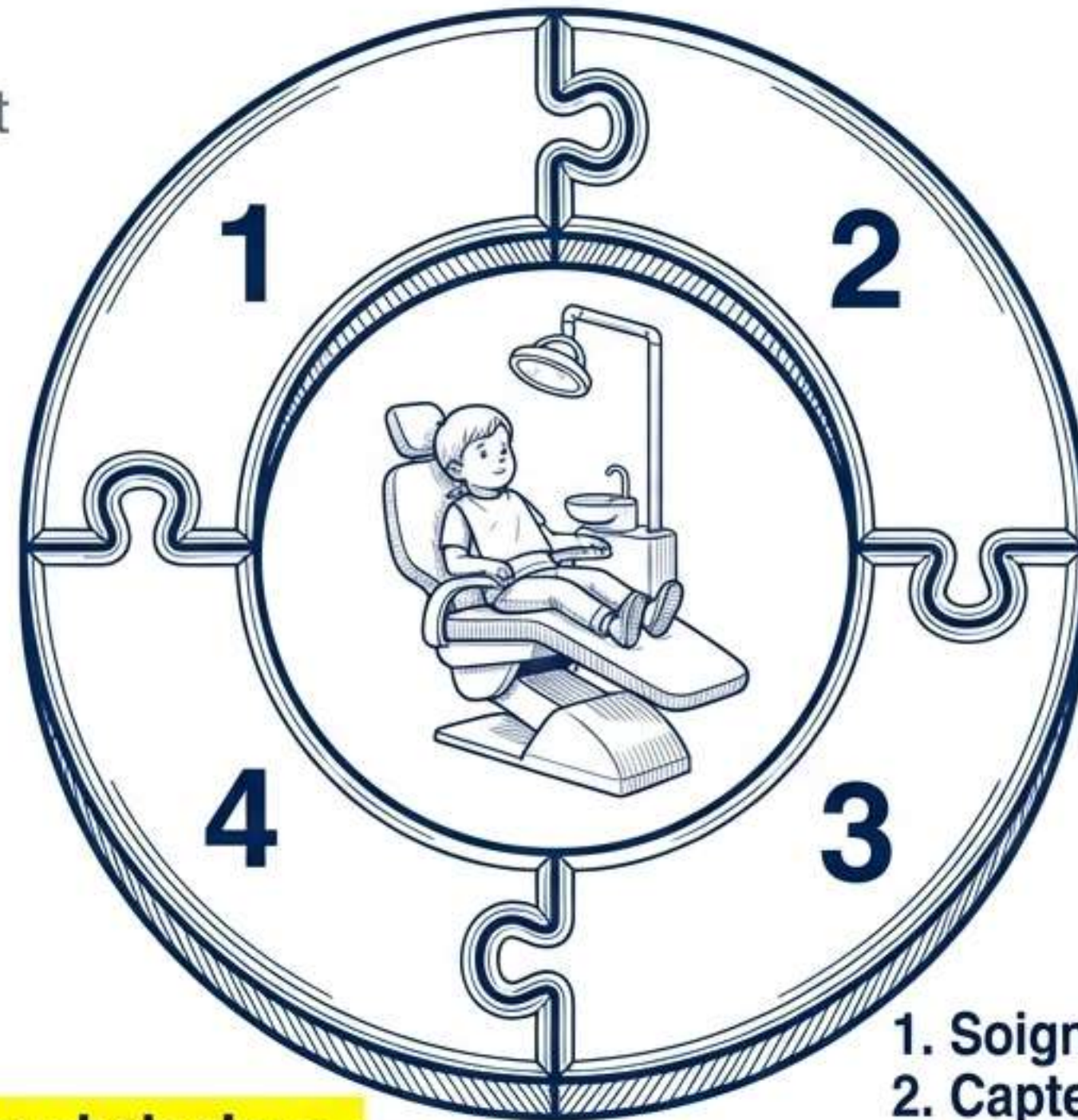
Stade III : « Attitude positive » : l'enfant accepte le traitement ; mais reste méfiant
[Ref: Q15 (2021), Q6 (2023)]

Stade VI* : « Attitude extrêmement positive » : l'enfant s'intéresse au traitement, plaisante.
(Note : Stade VI fidèlement retranscrit du cours)

3. Rencontre dans la pratique des soins

L'enfant est sur le fauteuil, il ne s'oppose pas, mais l'anxiété n'est pas surmontée et reste prête à se manifester.

Objectif : Apprivoiser l'enfant (par notre attitude, paroles, gestes, façon de pratiquer).



Les 4 Moyens de l'Approche Psychologique :

Nous disposerons des moyens suivants : [Ref: Q17 (2021)]

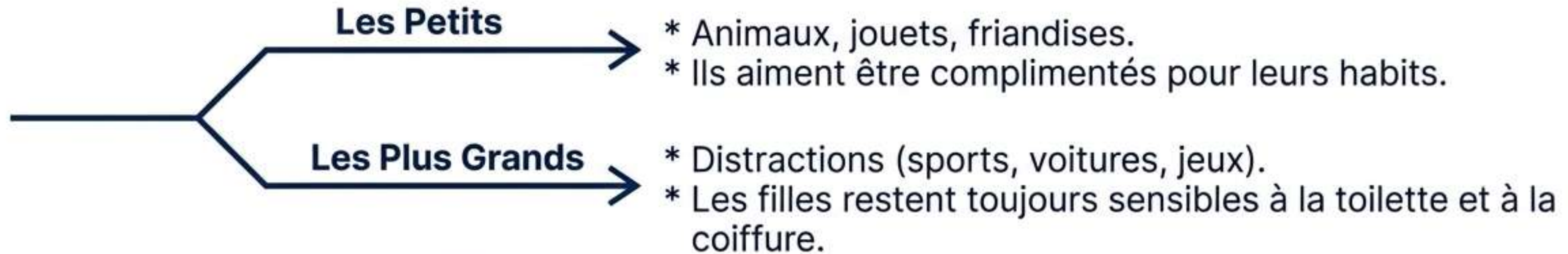
1. Soigner par la parole
2. Capter l'attention
3. Dédramatiser les instruments
4. Observer une progression dans les soins

3-1 Soigner par la parole (Esculape)

- * **Parler à l'enfant et le faire parler** (apaiser, détourner l'attention, connaître, créer des liens). Efficacité dépend du tempérament.
- * **Le silence** : Toujours impressionnant ; le silence ne doit pas s'installer.
- * **Langage et Âge mental** : Éviter termes techniques trop évalués (inquiétant), mais ne pas le traiter comme un bébé (humiliation).

Communication verbale 	Communication non verbale  
Appeler l'enfant par son prénom [Ref: Q8 (2023)] Paroles appropriées à l'âge (chanson: petits, histoire: grands). Ton monotone et voix douce ou apaisante. Éviter tout terme agressif (douleur, peine, mal, peur, piquêre) [Ref: Q8 (2023)] Toujours dire ce que l'on va faire et faire ce que l'on dit.	Prendre un enfant par la main. Avoir des gestes attentionnés (toucher la main, la joue, l'épaule) et toujours lents et non précipités. Échanger les regards et ne pas perdre le contact visuel/physique. Créer une ambiance apaisante et rassurante (lumineux, couleurs, dessins d'enfant, jeu).

3-2 Capter l'attention (Détourner l'attention)



La Promesse de Récompense :

L'enveloppe magique : Remise au patient dès le début de la séance (enveloppe brillante et colorée dont on ne sait ce qu'elle contient). [Predicted - Méthode de psychologie spécifique au cours]

Effet : Ce seul mot intrigue l'enfant pendant les soins, il est pressé d'en dévoiler le secret.

3-3 Dédramatiser les instruments (Principes physiologiques)



Âge < 7 ans

Âge > 8 ans

Moins de 7 ans : Ne pas compter d'emblée sur les explications et le raisonnement. [Predicted - Borne d'âge critique]

Un petit enfant est incapable de **distinguer** un instrument qui fait mal d'un autre.

Après 8 ans : Donner des explications (rôle de chaque chaque outil, déroulement) et minimiser les actes ('petite piqûre', 'petit traitement').

Techniques de Dédramatisation par Comparaison (Monde Familier) :

Familiarisation tactile : Faire toucher le miroir, pompe à salive, rouleau de coton, seringue à eau/air. [Ref: Q8 (2023)]

Spray d'anesthésie



Vaporisateur d'eau fraîche

L'anesthésie



Piqûre de moustique qui fera dormir la dent

La Fraise



Enlève le noir



rassuré car ne fait pas mal



Le Dictionnaire de Traduction (Vocabulaire Imagé)

Se faire rapporter ce qui peut effrayer à autre chose qui ne fait pas peur.
[Predicted - Tableau central de mémorisation]

Termes techniques	Termes imagés
Ouvre la bouche	Fait le crocodile
La piquûre	Le petit moustique
L'appareil radiographique	La caméra magique
Pâte à empreinte	Pâte à modeler et moulage
Le mordançage	La peinture bleue



3-4 Observer une progression dans les soins

Règle d'or : Il ne faudra JAMAIS commencer par une extraction (acte le plus redouté). [Predicted - Règle d'exclusion absolue]



Première visite : Regarder et compter les dents, d'abord sans miroir (au besoin sans le faire asseoir sur le fauteuil).

Étapes suivantes : Parler de nettoyer la dent avec une "brosse qui tourne".

Tolérance : Éviter toute douleur insupportable. L'acte doit être bref et efficace.

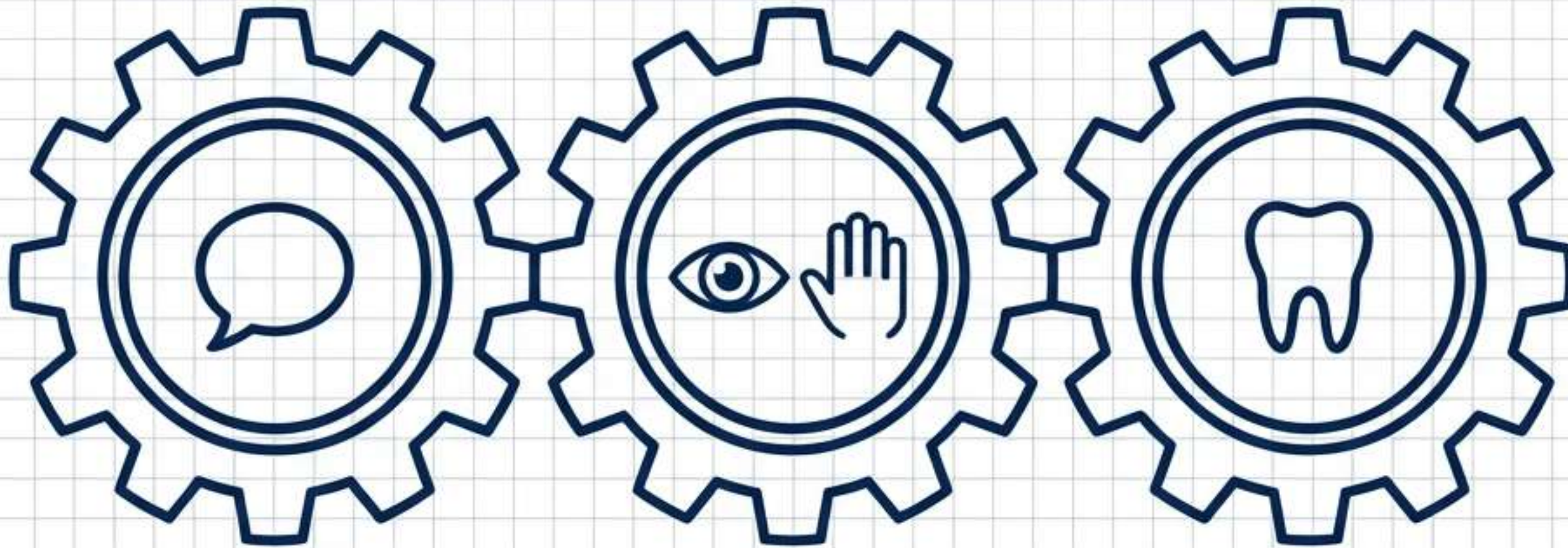
- **Gestion de l'échec ("ratage") :** Contrairement à la règle générale, si échec lors d'une séance -> éloigner le rendez-vous suivant (lui laisser le temps d'oublier).
- **Empreinte :** Généralement reportée à la séance suivante.

4. Méthode Tell-Show-Do (ADLESTON)

La méthode la plus populaire pour contrôler le comportement des enfants. Ne plus cacher le matériel.

Principe de base : Toujours dire ce que l'on va faire et faire ce que l'on dit. [Ref: Q19 (2024)]

La séquence d'Adleston (Expliquer, Montrer, Faire) : [Ref: Q7 (2023)]



1. TELL (Expliquer) :

Expliquer le rôle de chaque instrument avant son utilisation [Ref: Q16 (2021)] avec vocabulaire adapté. Solliciter les sens (regarder, toucher, manipuler, écouter, sentir).

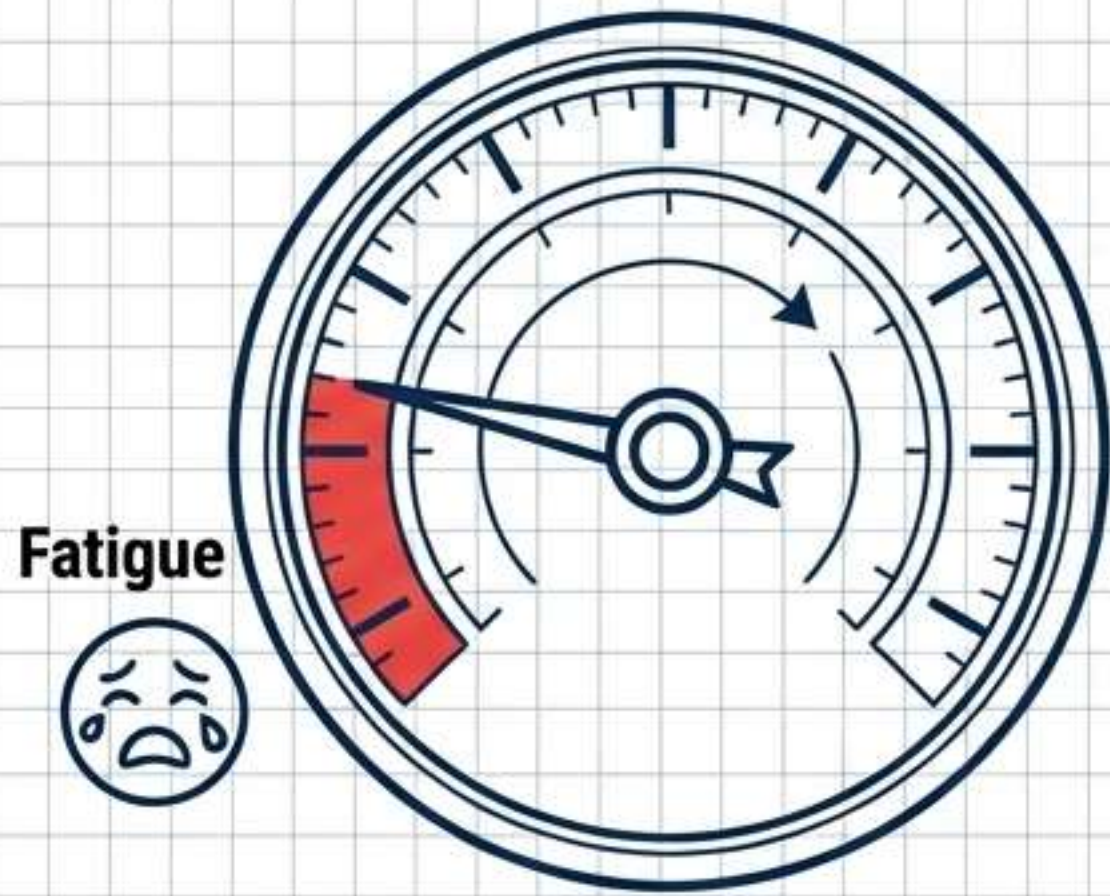
2. SHOW (Montrer) :

Montrer le fonctionnement sur un doudou, un parent ou sa main (ex: fraise contre angle vitesse réduite = 'ça fait des chatouilles') pour prouver l'absence de douleur.

3. DO (Faire) :

Réaliser l'acte après s'être assuré qu'il a bien compris, en continuant à expliquer chaque étape calmement.

Facteurs Physiologiques et Environnement



Fatigue physique : Enfant fatigué (sortie d'école) = acuité sensorielle accrue (ressent davantage la douleur). Il est irritable, crie et pleure. [Ref: Q20 (2024)]

Solution : Différer les soins ; choisir généralement le matin.



Le pouvoir de contrôle : OPTON (1969) suggère de donner au moins l'illusion d'un contrôle en lui remettant une petite glace. [Predicted - Nom d'auteur]

Autres facteurs : Temps de repos & W.C.

Conclusion : Les enfants constituent 90% du total des patients consultants en ODF. [Predicted - Statistique épidémiologique]
Tous les membres de l'équipe dentaire doivent s'entendre sur cette approche psychologique commune.

Bibliographie : Bourassa (1991), Friedman (1996), Varella (2011).

Exam Pattern Analysis (Stratégie de Mémorisation)

Top QCM (Sujets Répétés)

- **La méthode Tell-Show-Do (ADLESTON)** : Comprendre la définition exacte de chaque étape et la séquence inaltérable.



- **Classification de Frankl** : Maîtriser parfaitement le vocabulaire des Stades I, II et III (Définitif négatif vs Négatif vs Positif méfiant).

Stade	Descripteur
Stades I	Compavimar vs définitif négatif
Stades II	Compavimiseo: définitif négatif
Stades III	Compatenteur vesitin idfranif
Stades II	Conbavimaur vs positif méfiant

- **Termes prescrits/proscrits** : Appeler par le prénom, interdiction des mots "douleur", "piqûre".



Pièges Récurrents

- **L'autoritarisme** : Autorité + amitié oui, mais JAMAIS d'approche strictement 'autoritaire' ou de séparation forcée des parents.

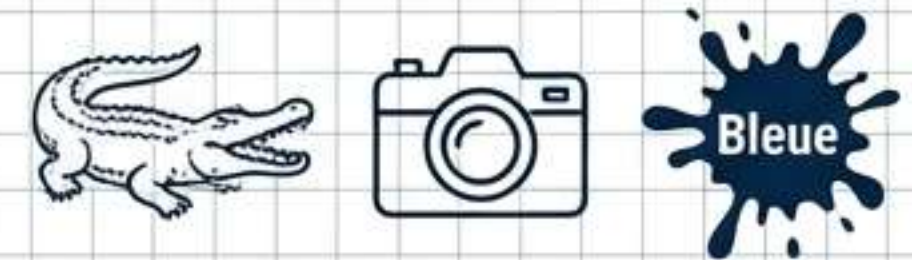


- **Fatigue** : L'enfant fatigué ne s'endort pas : son acuité sensorielle (douleur) augmente.



Prédications (Green Targets)

- **Correspondance exacte du vocabulaire** (Crocodile, Caméra, Peinture bleue).



- **Les noms d'auteurs secondaires** : **OPTON** (glace de contrôle), **RUEL-KELLERMANN** (citation sur la peur).



Carte Mentale : L'Approche Psychologique (Dr MELOUAH)

